VIA MEDICA

Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2022
tom 7, nr 4, strony 226–229
Copyright © 2022 Via Medica
ISSN 2451–0122
e-ISSN 2451–1943

Stanowisko Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczące stosowania produktu leczniczego Slinda® — jednoskładnikowej antykoncepcji progestagennej zawierającej 4 mg drospirenonu

Experts' position of the Polish Society of Gynecologists and Obstetricians regarding the use of the medicinal product Slinda®— progestogen-only contraception containing 4 mg of drospirenone

Agnieszka Drosdzol-Cop[1], Artur Jakimiuk[2, 3], Anita Olejek[4], Robert Spaczyński[5], Piotr Sieroszewski[6]

[1]Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
[2]Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
[3]Zakład Zdrowia Prokreacyjnego, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
[4]Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
[5]Centrum Ginekologii, Położnictwa i Leczenia Niepłodności Pastelowa w Poznaniu
[6]I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Klinika Medycyny Płodu i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

WSTĘP

Złożona dwuskładnikowa (estrogenowo-progestagenna) antykoncepcja hormonalna (CHC, *combined hormonal contraception*) jest dobrze akceptowana, zapewnia skuteczną ochronę, ma niski profil ryzyka zdrowotnego i zapewnia dodatkowe korzyści pozaantykoncepcyjne.

Z medycznego punktu widzenia głównym problemem związanym z jej stosowaniem jest jednak ryzyko występowania chorób sercowo-naczyniowych — dotyczące głównie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej [ŻChZZ (VTE, *venous thromboembolism*)], które jest na ogół niskie, ale sprawia, że CHC nie jest odpowiednia dla wszystkich kobiet, zwłaszcza dla tych z czynnikami ryzyka ŻChZZ [1, 2].

Zwiększone ryzyko wystąpienia ŻChZZ u zdrowych kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne,w porównaniu z niestosującymi CHC jest niepokojące i doprowadziło do rozpowszechnienia doustnych środków antykoncepcyjnych niezawierających estrogenu. Powyższe modyfikacje oparto na danych laboratoryjnych i epidemiologicznych wskazujących, że estrogenowy składnik CHC jest odpowiedzialny za zwiększone ryzyko schorzeń układu sercowo-naczyniowego, czego nie wykazano w przypadku preparatów zawierających wyłącznie progestagen [1–3].

PRZECIWWSKAZANIA DO STOSOWANIA ANTYKONCEPCJI HORMONALNEJ — KLASYFIKACJA ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO, *World Health Organization*) w 2015 roku uaktualniła wskazania dotyczące stosowania różnych metod antykoncepcji [2].

Adres do korespondencji: Agnieszka Drosdzol-Cop, Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, e-mail: cor111@poczta.onet.pl

Do grupy pacjentek, u których niezalecana/przeciwwskazana jest złożona dwuskładnikowa antykoncepcja hormonalna zalicza się kobiety obarczone czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym:
- palenie tytoniu — w szczególności powyżej 15 papierosów dziennie;
- nadciśnienie tętnicze — ciśnienie skurczowe ≥ 140 mm Hg lub/i rozkurczowe ≥ 90 mm Hg. Stosowanie złożonej antykoncepcji hormonalnej w tej grupie może zwiększyć 12-krotnie ryzyko zawału serca — złożona antykoncepcja hormonalna nie jest zalecana nawet u pacjentek z dobrze kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym;
- dyslipidemia;
- cukrzyca powikłana nefropatią, retinopatią czy neuropatią lub cukrzyca trwająca ponad 20 lat;
- wiek powyżej 40. roku życia (zgodnie z klasyfikacją WHO — MEC2 — stan, w którym korzyści z zastosowania metody zasadniczo przewyższają teoretyczne lub udowodnione ryzyko).

Do tej samej grupy WHO zaliczyła również kobiety obciążone:
- ŻChZZ lub zatorowością płucną w wywiadzie;
- aktualną lub przebytą chorobą niedokrwienną serca;
- mutacjami czynników układu krzepnięcia, na przykład mutacją czynnika V Leiden;
- incydentem naczyniowo-mózgowym w wywiadzie;
- długotrwałym unieruchomieniem po rozległych zabiegach chirurgicznych;
- powikłaną wadą zastawkową serca;
- obecnością przeciwciał antyfosfolipidowych;
- migreną bez aury powyżej 35. roku życia oraz migreną z aurą w każdym wieku;
- rakiem piersi obecnie czy w ciągu ostatnich 5 lat;
- guzami złośliwymi wątroby lub gruczolakiem wątrobowo-komórkowym.

W przypadku pacjentek obarczonych powyższymi czynnikami ryzyka należy unikać stosowania złożonej estrogenowo-progestagennej antykoncepcji hormonalnej na korzyść innej, cechującej się wyższym profilem bezpieczeństwa [1–4].

Poza wymienionymi przeciwwskazaniami istnieją również inne potencjalne czynniki przemawiające na niekorzyść terapii dwuskładnikowymi preparatami antykoncepcyjnymi. Kobiety nie zawsze dobrze znoszą powiązanie z nią działania niepożądane estrogenów i znaczna grupa kobiet (nawet do 33%) przerywa ich stosowanie ze względu na te nieakceptowane skutki uboczne (bóle głowy czy drażliwość piersi) [1, 3].

Istotnym, choć rzadkim działaniem niepożądanym CHC jest zwiększenie ryzyka występowania powikłań zakrzepowo-zatorowych, a na podstawie przeprowadzonej analizy składu hormonalnych tabletek antykoncepcyjnych stwierdzono, że zawarty w nich składnik estrogenowy niekorzystnie oddziałuje na układ hemostazy, między innymi obniża stężenie antytrombiny III, podwyższa stężenia fibrynogenu oraz zwiększa zdolność płytek krwi do agregacji [4–6].

Działaniem alternatywnym było wprowadzenie na rynek nowego, jednoskładnikowego, progestagennego produktu leczniczego Slinda®, który został zarejestrowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej jako jednoskładnikowa antykoncepcja progestagenna nowej generacji (w 2019 roku).

Produkt leczniczy Slinda® zawiera drospirenon w dawce 4 mg stosowany w schemacie 24/4 i cechuje się wyższym stopniem akceptacji wśród pacjentek, ze względu na zaobserwowaną mniejszą liczbę dni krwawień i plamień, w stosunku do innych preparatów progestagennych. Produkt leczniczy Slinda® wyróżnia się też wyraźnie mniejszym wskaźnikiem przerywania stosowania przez pacjentki w porównaniu do dezogestrelu [4, 5, 7].

PROFIL METABOLICZNY PRODUKTU LECZNICZEGO SLINDA® JAKO JEDNOSKŁADNIKOWEJ ANTYKONCEPCJI PROGESTAGENNEJ Z DROSPIRENONEM

Według raportu przygotowanego w 2020 roku przez Główny Urząd Statystyczny, najczęstszą przyczynę zgonów kobiet stanowią choroby układu krążenia [8]. U coraz większej liczby pacjentek obecne są czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych:
- otyłość;
- palenie tytoniu;
- cukrzyca.

Wydaje się, że wraz z postępem cywilizacyjnym oraz rosnącą liczbą chorób i obciążeń genetycznych coraz istotniejsze jest zwrócenie uwagi na wybór odpowiedniej metody antykoncepcji.

Najważniejszą zaletą jednoskładnikowej antykoncepcji hormonalnej jest profil bezpieczeństwa względem chorób układu sercowo-naczyniowego. W żadnym z badań klinicznych u pacjentek stosujących drospirenon w dawce 4 mg nie wystąpił epizod ŻChZZ ani nie stwierdzono w tej grupie zmian parametrów hemostazy dających efekt prozakrzepowy.

Co więcej, w przypadku stosowania produktu leczniczego Slinda® (drospirenon w dawce 4 mg) dochodzi do spadku stężenia jednego z biomarkerów — d-dimerów, które są powszechnie uznawanym markerem aktywacji układu krzepnięcia jako istotny wskaźnik w diagnostyce incydentów zakrzepowo-zatorowych oraz przewidywania ich nawrotów [4, 6].

Natomiast, u pacjentek normotensyjnych preparat nie wpływał na wartość ciśnienia tętniczego krwi (BP, *blood pressure*), podczas gdy u kobiet z podwyższonymi wartościami wyjściowymi ciśnienia tętniczego (skurczowe

BP > 130 mm Hg, rozkurczowe > 85 mm Hg) dochodziło do jego nieznacznego obniżenia [4, 6].

Jako że ryzyko wystąpienia incydentów zakrzepowo-zatorowych wzrasta wraz z wiekiem, ordynowanie po raz pierwszy złożonych preparatów antykoncepcji hormonalnej kobietom w wieku powyżej 40. roku życia powinno być dokonywane po dokładnej analizie obrazu klinicznego pacjentki. Bardzo istotne jest, aby w grupie kobiet w wieku okołomenopauzalnym rozważyć zastosowanie jednoskładnikowej antykoncepcji progestagennej, jako alternatywy dla złożonej dwuskładnikowej antykoncepcji hormonalnej [4, 9].

Co istotne, w czasie stosowania produktu leczniczego Slinda® — czyli drospirenonu w dawce 4 mg według schematu 24/4, stężenie estradiolu w surowicy krwi utrzymuje się na poziomie około 50 pg/ml, odpowiadając wczesnej fazie folikularnej. Zatem preparat ten, mimo że pozbawiony estrogenu (czynnika odpowiedzialnego za hamowanie resorpcji tkanki kostnej), nie powinien mieć negatywnego wpływu na proces metabolizmu tkanki kostnej.

Potwierdzają to wstępne wyniki badań obserwacyjnych, jednakże ostateczne wnioski będą dostępne za kilka lat, po zakończeniu follow-up [10].

Wyniki badań wykazały również brak istotnego wpływu przyjmowania jednoskładnikowej antykoncepcji progestagennej na zwiększenie masy ciała pacjentek. W większości publikacji wykazano, że średnie wahania masy ciała po 6–12 miesiącach stosowania doustnej jednoskładnikowej antykoncepcji progestagennej były nieistotne statystycznie i wynosiły mniej niż 2 kg, co wydaje się szczególnie korzystne, biorąc pod uwagę ryzyko występowania chorób układu krążenia u kobiet po 40. roku życia [11].

Co bardzo istotne, skuteczność w zakresie zapobiegania ciąży produktu leczniczego Slinda® jako jednoskładnikowej antykoncepcji progestagennej z drospirenonem jest wysoka. Wskaźnik Pearla jednoskładnikowego preparatu progestagennego jest porównywalny z dwuskładnikowymi preparatami antykoncepcyjnymi i wynosi 0,73 [4].

Dodatkowo, jak pokazują wyniki badań, produkt leczniczy Slinda® (drospirenon w dawce 4 mg) wywiera niewielki wpływ na proliferację endometrium u kobiet — powoduje zmniejszenie średniej grubości endometrium. Nie stwierdzono też przypadków jego rozrostu [12].

Pandemia COVID-19 wymusiła wprowadzenie wielu istotnych zmian w codziennej ginekologicznej praktyce lekarskiej, w tym również tych, dotyczących poradnictwa antykoncepcyjnego. Z pewnością należy przykładać zwiększoną uwagę do profilu bezpieczeństwa antykoncepcji hormonalnej zalecanej pacjentkom, zwłaszcza tym, które są obciążone czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Zakażenie SARS-CoV-2 prowadzi do ogólnoustrojowych odpowiedzi zapalnych związanych również z aktywacją procesu krzepnięcia, co także skutkuje zwiększoną szansą wystąpienia incydentów zakrzepowo-zatorowych, a w badaniach opublikowanych w ciągu kilku ostatnich dekad wykazano, że złożona (estrogenowo-progestagenna) antykoncepcja hormonalna zwiększa w niektórych sytuacjach klinicznych ryzyko ŻChZZ [13].

Jak pokazują wyniki przytoczonych wcześniej badań, produkt leczniczy Slinda® zawierający tylko 4 mg drospirenonu nie wpływa na parametry hemostazy. Fakt ten wydaje się szczególnie istotny w momencie wyboru najlepszej metody antykoncepcji dla pacjentek narażonych na zakażenie SARS-CoV-2, niezależnie od obecności czynników ryzyka sercowo-naczyniowego [14].

Ze względu na korzystny profil bezpieczeństwa, zwłaszcza w aspekcie ryzyka ŻChZZ, produkt leczniczy Slinda®, w formie tabletki antykoncepcyjnej zawierającej wyłącznie progestagen, wydaje się metodą pierwszego wyboru w omawianej grupie kobiet [14].

WNIOSKI

Produkt leczniczy Slinda® — jednoskładnikowa doustna antykoncepcja hormonalna zawierająca 4 mg drospirenonu charakteryzuje się wysokim profilem bezpieczeństwa względem chorób układu sercowo-naczyniowego. Nie wykazuje wpływu na parametry hemostazy, jest zatem korzystny dla pacjentek z czynnikami ryzyka jak otyłość, nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca. Produkt nie wpływa negatywnie na metabolizm tkanki kostnej ani nie powoduje istotnego zwiększenia masy ciała kobiet.

Ze względu na korzystny profil bezpieczeństwa (zwłaszcza w aspekcie ŻChZZ wydaje się, iż produkt leczniczy Slinda®, jako antykoncepcja progestagenna z drospirenonem, może być metodą z wyboru dla wszystkich kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem:

- kobiet po 40. roku życia;
- kobiet obciążonych czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego;
- kobiet zagrożonych bądź chorujących na cukrzycę;
- kobiet zagrożonych otyłością;
- kobiet palących tytoń.

Konflikt interesów

Autorzy nie zgłaszają konfliktu interesów.

Piśmiennictwo

1. European Medicines Agency. Combined hormonal contraceptives. www.ema.europa.eu/en/medicines/human/referrals/combined-hormonal-contraceptives (DATA DOSTĘPU!).
2. WHO Medical eligibility criteria for contraceptive use. 5th ed. Geneva, 2015.

3. De Leo V, Musacchio MC, Cappelli V, et al. Hormonal contraceptives: pharmacology tailored to women's health. Hum Reprod Update. 2016; 22(5): 634–646, doi: 10.1093/humupd/dmw016, indexed in Pubmed: 27307386.
4. Palacios S, Regidor PA, Colli E, et al. Oestrogen-free oral contraception with a 4 mg drospirenone-only pill: new data and a review of the literature. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2020; 25(3): 221–227, doi: 10.1080/13625187.2020.1743828, indexed in Pubmed: 32312141.
5. Palacios S, Colli E, Regidor PA. Multicenter, phase III trials on the contraceptive efficacy, tolerability and safety of a new drospirenone-only pill. Acta Obstet Gynecol Scand. 2019; 98(12): 1549–1557, doi: 10.1111/aogs.13688, indexed in Pubmed: 31321765.
6. Palacios S, Colli E, Regidor P. Efficacy and cardiovascular safety of the new estrogen-free contraceptive pill containing 4 mg drospirenone alone in a 24/4 regime. BMC Womens Health. 2020; 20(1): 218, doi: 10.21203/rs.3.rs-28911/v2.
7. Regidor PA, Palacios S, Colli E. Bleeding profile of women with cardiovascular risk factors using a drospirenone only pill with 4 mg over nine cycles compared to desogestrel 0.075 mg. Gynecol Endocrinol. 2022; 38(4): 333–338, doi: 10.1080/09513590.2022.2046729, indexed in Pubmed: 35261299.
8. Główny Urząd Statystyczny. Umieralność w 2020 roku, Zgony według przyczyn — dane wstępne. 28.06.2021 r.
9. Palacios S, Colli E, Regidor PA. Metabolic and laboratory effects of a progestin-only pill containing drospirenone 4 mg in comparison to desogestrel 75 µg: a double-blind, double-dummy, prospective, randomised study. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2021; 26(6): 454–461, doi: 10.1080/13625187.2021.1957094, indexed in Pubmed: 34348526.
10. Hadji P, Colli E, Regidor PA, et al. Bone health in estrogen-free contraception. Osteoporos Int. 2019; 30(12): 2391–2400, doi: 10.1007/s00198-019-05103-6, indexed in Pubmed: 31446440.
11. Lopez LM, Ramesh S, Chen M, et al. Progestin-only contraceptives: effects on weight. Cochrane Database Syst Rev. 2016(8): CD008815, doi: 10.1002/14651858.CD008815.pub4, indexed in Pubmed: 27567593.
12. Römer T, Bitzer J, Egarter C, et al. Oral Progestins in Hormonal Contraception: Importance and Future Perspectives of a New Progestin Only-Pill Containing 4 mg Drospirenone. Geburtshilfe Frauenheilkd. 2021; 81(9): 1021–1030, doi: 10.1055/a-1471-4408, indexed in Pubmed: 34565826.
13. Lete I. Combined hormonal contraception and COVID-19. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2021; 26(2): 128–131, doi: 10.1080/13625187.2020.1867845, indexed in Pubmed: 33475429.
14. Paszkowski T, Jakimiuk A, Jerzak M, et al. Antykoncepcja hormonalna w dobie pandemii COVID-19. Ginekologia po Dyplomie. 2020: 1–4.